

Грижа в края на живота

Терминално болният пациент, палиативни грижи и хоспис, евтаназия и медицински асистирано самоубийство

Упражнение 5 · СММЕ — I част · 2026/2027

гл. ас. д-р Костадин Костадинов, д.м.

Катедра „Социална медицина и обществено здраве“

Пет въпроса за днешното упражнение

1. Терминално болният пациент
2. Палиативни грижи и хоспис
3. Евтаназия и асистирано самоубийство: понятия и видове
4. Нормативна рамка
5. Аргументи и философски позиции

Терминално болният пациент

Неизлечимо, терминално, умиращ

Понятие	Значение	Пример
Неизлечимо	Не може да се премахне, но може да се контролира с години	Сърдечна недостатъчност, множествена склероза
Терминално	Прогресира; лечението вече не променя прогнозата за живота	Метастатичен карцином след изчерпано лечение
Умиращ	Започнало е необратимо угасване на жизнените функции	Последните часове или дни

ЗЛЗ, § 1, т. 4 ДР: терминално болни са лица с прогресиращи и неизлечими заболявания, при които лечението не променя неблагоприятната прогноза за продължителността на живота.

Етични проблеми в края на живота

Истина и прогноза

Колко, кога и на кого;
молбата на близките
диагнозата да се скрие.

Пропорционалност

Терапевтично упорство
срещу изоставяне;
безполезна.

Отказ

Способен пациент
отказва диализа,
вентилация или
операция.

Реанимация

Решение за
непредприемане на
реанимация — преди
кризата.

Неспособност

Кой говори за пациента:
предишна воля, близки,
най-добър интерес.

Справедливост

Достъп до грижа
независимо от диагноза,
място и доход.

Терминално болният запазва всички права на пациент

Разпоредба	Съдържание
33, чл. 90	Отказ от предложената помощ или от продължаването ѝ по всяко време; удостоверява се с подписи.
33, чл. 91	Помощ против волята на пациента — само в случаи, определени със закон.
33, чл. 92, ал. 2 и 4	Право да не узнае прогнозата; писмено упълномощено лице да бъде информирано вместо него.
Кодекс, чл. 29	При отказ поради непознаване на опасностите лекарят разяснява прогнозата без лечение.

Правото да не знаеш принадлежи на пациента, не на семейството.

Незапочване, прекратяване и пропорционалност

Незапочване = прекратяване

Двете могат да имат еднакво етично основание. Пробен период, който не постига целта, не продължава безкрай.

Без реанимация

Само реанимацията при арест.
Обезболяване, кислород, течности и присъствие продължават.

Пропорционално лечение

Ползата отговаря на товара спрямо целите на **този** пациент.
Безполезността е клинична преценка, не „живот, който не си струва“.

Хранене и хидратиране

Медицински намеси със свои показания; никога „оставяне да гладува“.

Казус 1 · Седмата диализа

Мъж на 60 години с диабет и тежка бъбречна недостатъчност спира да идва след шест процедури хемодиализа. По телефона казва, че не иска остатъкът от живота му да бъде подчинен на диализата. При последния преглед е бил ориентиран, но потиснат, и е споделил, че се чувства тежест за семейството. Знае, че прекратяването вероятно ще доведе до смърт.

- Евтаназия ли е прекратяването на диализата?
- Какво трябва да се изясни, преди отказът да бъде приет?
- Какви задължения остават, ако го потвърди при запазена способност?

Палиативни грижи и хоспис

Какво са палиативните грижи

СЗО (2002): подход, който подобрява качеството на живот на пациентите и семействата им при животозастрашаващо заболяване чрез предотвратяване и облекчаване на страданието — ранно разпознаване, безупречна оценка и лечение на болката и другите физически, психосоциални и духовни проблеми.

- Не само при рак и не само в последните дни: започват според потребностите.
- Могат да вървят успоредно с лечението на заболяването.
- Ранните палиативни грижи подобряват качеството на живот и настроението (Temel et al., 2010).

Цели на палиативните грижи

1

Облекчаване
на болка и
симптоми

2

Нито ускорява,
нито отлага
смъртта

3

Психосоциална
и духовна
подкрепа

4

Възможно най-
активен живот

5

Подкрепа на
семейството и
в скръбта

33, чл. 95, ал. 2: цел е поддържане на качеството на живот чрез намаляване или премахване на проявите на болестта и на неблагоприятните психологични и социални ефекти.

Палиативните грижи са активно лечение, а не край на лечението.

Тотална болка и три пресичащи се понятия

Понятие	Обхват	Кога
Палиативна грижа	Облекчаване на страданието при тежко, ограничаващо живота заболяване	От диагнозата, според нуждите
Грижа в края на живота	Комфорт и планиране, когато смъртта се очаква скоро	Последни месеци, седмици, дни
Хосписна грижа	Организирана палиативна грижа при напреднало заболяване, с подкрепа за семейството	Ограничена прогноза; цел комфорт

Тотална болка (Сисли Сондърс): физическото, психологичното, социалното и духовното страдание се усилват взаимно.

Хоспис и палиативни грижи в българското право

ЗЗ, чл. 95–96

Право на палиативни грижи при нелечимо заболяване с неблагоприятна прогноза.

Наблюдение, премахване на болката и страданието, морална подкрепа.

Оказват ги личният лекар, извънболничната и болничната помощ и хосписите. Изисквания — с наредба (чл. 96, ал. 3).

ЗЛЗ, чл. 10 и 28

Хосписът е лечебно заведение, в което специалисти осъществяват палиативни грижи за терминално болни; може да предоставя и социални услуги.

Празнотата: наредбата по чл. 96, ал. 3 не е издадена; липсва ясен механизъм за обема и контрола на палиативната грижа (Илиева и Мусурлиева, 2023).

Опиоиди и принципът на двойния ефект

1

Действието е добро
или неутрално

2

Цели се само
добрият ефект

3

Вредата не е
средство

4

Съразмерна
причина

- Титрираните опиоиди са обичайно медицинско задължение; по правило не ускоряват смъртта.
- Намерението личи от показанието, дозата, темпа на увеличаване, наблюдението и документацията.
- Смъртоносна доза с цел смърт не е „обезболяване“.

Палиативна (терминална) седация

Показание

Рефрактерен симптом: няма ефективно лечение в приемлив срок или при приемлив товар. Крайна мярка след специализирана оценка.

Пропорционалност

Най-ниското ниво, което облекчава; първо лека или периодична. Продължителна дълбока седация — само в последните часове или дни.

Съгласие и документация

Информирано решение; документират се симптомът, предишните опити, схемата и наблюдението.

Не е евтаназия

Целта е облекчение; смъртта не е нито цел, нито средство.

Казус 2 · Увеличаването на дозата

Мъж на 74 години с метастатичен малигнен меланом е на легло и получава опиоид по постоянна схема, но от два дни има почти непрекъсната болка и болезнени пристъпи при движение. При домашно посещение моли за „най-силната доза, каквото и да стане“. Дъщеря му се противопоставя: страхува се, че морфинът ще потисне дишането и ще ускори смъртта.

- Защо „болка или смъртоносна доза“ е фалшив избор?
- Каква оценка предшества промяната на аналгезията?
- Как ще обясните двойния ефект на дъщерята?

Евтаназия и асистирано самоубийство: понятия и видове

Кой извършва последното действие?

Практика	Последно действие	Намерение	Причина за смъртта
Евтаназия	Лекарят	Да причини смърт по валидна молба	Приложеното средство
Медицински асистирано самоубийство	Пациентът, със средство от лекар	Пациентът прекратява живота си	Приетото средство
Отказ / прекратяване	Няма смъртоносно действие	Уважаване на отказа; без безполезно лечение	Основното заболяване
Палиативна седация	Екипът, пропорционална доза	Облекчаване на рефрактерно страдание	Прогресиращото заболяване

Етимология: гр. *eu* (добър) + *thanatos* (смърт). „Добрата смърт“ е по-широко понятие от евтаназията.

Класически видове евтаназия

Критерий	Видове	Съвременна оценка
По действието	Активна: действие причинява смъртта. Пасивна: лечение не се започва или се прекратява	„Пасивна евтаназия“ е подвеждащо: пропорционалното прекратяване не е евтаназия
По волята	Доброволна (по молба), недоброволна (без способност), принудителна (против волята)	Само доброволната може да е евтаназия; принудителната е убийство
По намерението	Директна: смъртта е цел. Индиректна: предвидена, но не цел	Индиректната = двоен ефект; не е евтаназия
По извършителя	Евтаназия или (медицински) асистирано самоубийство	Решава кой извършва последното действие

Какво не е евтаназия

Не е евтаназия

- Отказ на способен пациент.
- Незапочване или прекратяване на безполезно лечение.
- Титрирано обезболяване.
- Пропорционална палиативна седация.

Четири въпроса

- Какво се прави?
- Какво се цели?
- От какво настъпва смъртта?
- Продължава ли грижата?

Близките не могат да поискат евтаназия вместо пациент без способност за решение.

„Искам да умра“: молба, която изисква отговор

1

Попитайте
какво е
непоносимо

2

Оценете
симптоми,
настроение,
способност,
риск

3

Лекувайте
поправимото

4

Обяснете
правните
граници

5

Обещайте да
не изоставите

„Не мога да извърша или подпомогна това действие, но искам да разбера какво прави положението непоносимо и как можем да Ви помогнем сега.“

Нормативна рамка

България: евтаназията е забранена

Акт	Разпоредба
Конституция, чл. 28	Всеки има право на живот; посегателството върху него се наказва като най-тежко престъпление.
ЗЗ, чл. 97	На територията на Република България не се прилага евтаназия.
Кодекс за професионална етика, чл. 30, 31	Лекарят няма право да прекъсва живота на пациента; прави всичко възможно за живот без болки, при съхранено достойнство.
НК, чл. 115, 116	Няма привилегирован състав „убийство по молба“: умишленото умъртвяване е убийство; съгласието не оправдава.
НК, чл. 127	Подпомагането или склоняването към самоубийство е престъпление, ако последва самоубийство или опит.

Забраната не отменя правото на отказ от лечение и правото на палиативни грижи.

Съветът на Европа, Страсбург и СМА

Източник	Основна позиция
Прети с/у Обединеното кралство (2002)	Чл. 2 не дава право на смърт; общата забрана може да е пропорционална.
Хаас с/у Швейцария (2011)	Решението как и кога да умреш попада в чл. 8; държавите имат широка свобода.
Ламбер с/у Франция (ГК, 2015)	Прекратяването на храненето при вегетативно състояние не нарушава чл. 2.
Мортие с/у Белгия (2022)	Нарушение на чл. 2 заради зависим контрол, не заради закона за евтаназията.
Карсаи с/у Унгария (2024)	Няма задължение за допускане на помощ при умиране; палиативните грижи са съществени.
Овиедо, чл. 9; ПАСЕ, Рез. 1859 (2012)	Предидните желания се вземат предвид; евтаназията трябва да остане забранена.
СМА (Тбилиси 2019; Венеция 2022)	Твърдо против евтаназия и асистирано самоубийство; палиативната грижа е добра медицина.

Кратък световен преглед (октомври 2026)

Модел	Юрисдикции
Евтаназия и асистирано самоубийство	Нидерландия, Белгия, Люксембург, Канада (MAID), Испания, Колумбия, Нова Зеландия, австралийските щати и АСТ
Само евтаназия	Уругвай (2025)
Само асистирано самоубийство	Швейцария (без користен мотив), Орегон и над десет юрисдикции в САЩ, вкл. Ню Йорк (2026), Австрия, Германия и Италия (по съдебни решения)
Обсъжда се или не е в сила	Франция (2026, конституционен контрол), Англия и Уелс, Шотландия (отхвърлен), Португалия, Словения (референдум „не“)
Забранено	България и повечето държави от Съвета на Европа

Където е разрешено: 0,3–4,6% от смъртните случаи, над 70% рак; болката рядко е основният мотив (Emanuel et al., 2016).

Аргументи и философски позиции

Аргументи за и против

За разрешаване

- Автономност над собствената смърт.
- Състрадание: не всяко страдание се облекчава.
- Достойнство като живот по свои ценности.
- Прозрачност вместо скрита практика.

Против

- Присъщата ценност на живота; ролята на лечителя.
- Несигурна прогноза, необратимо действие.
- Натиск върху възрастни, бедни, хора с увреждания.
- Хлъзгав склон; първо палиативни грижи.

„Достойнство“ и „да не се вреди“ служат и на двете страни: първо ги определете.

Философски позиции

Позиция	Основна теза за решенията в края на живота
Автономност (Мил)	Способният човек решава за собствения си живот; правото на отказ не е право да задължиш друг да убие.
Светост на живота	Животът е неприкосновен и не се прекратява умишлено; това не изисква безкрайно лечение.
Кант	Личността има достойнство, а не цена; да прекратиш живота си, за да избягаш от страданието, е да се използваш само като средство.
Утилитаризъм	Минимум страдание (Сингър); но и доверието в медицината и рискът за уязвимите.
Хлъзгав склон	Логически: основанията излизат извън терминалното заболяване. Емпирично: данните са спорни.
Хипократова традиция	„Няма да дам смъртоносно средство на никого, дори да ме помоли.“

Казус 3 · Документите за чужбина

Жена на 60 години с амиотрофична латерална склероза има запазена способност за решение и общува чрез устройство за проследяване на погледа. Исква да кандидатства пред организация в държава, в която асистираното самоубийство е допустимо. Моли невролога си за подробно медицинско резюме, преведени резултати и пряк контакт с организацията.

- Къде е границата между правото ѝ на документацията и улесняването на самоубийство?
- Какво да ѝ предложи неврологът освен отказ?
- Кога е нужна юридическа и етична консултация?

Когато излекуването вече не е възможно,
грижата продължава да е дълг.

Нито изоставяне, нито упорство: облекчение, честност и
присъствие.